

TEMA 5.11 • OFTALMOLOGÍA

pérdida súbita de visión – resumen

PERFIL EUNACOM 6.02.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Pérdida Súbita de la Visión (Ojo Rojo Ausente)

Existen diversas patologías vasculares y neurológicas orgánicas que provocan un evento dramático y de angustia máxima: la pérdida súbita (amaurosis) de la agudeza visual de un **ojo**. Salvo excepciones, rara vez estas patologías afectan simultáneamente a ambos ojos al mismo tiempo de manera fulminante. Todas requieren evaluación y fondo de ojo perentorio y de urgencia.

A continuación, la división clásica de los síndromes oftalmológicos indolores (y con "ojo blanco", en general) que ciegan bruscamente a los pacientes:

1. Desprendimiento de Retina

Este cuadro, aunque dramático, suele ser el de instauración "más lenta" dentro del grupo rápido (horas a escasos días). - **Pródromos Patognomónicos**: - **Fotopsias**: Percepción destellante de "flashes" de luz. - **Entopsias (Midesopsias)**: Aparición repentina de densas manchas u "arañitas" flotando. - **Clínica Evolutiva**: El paciente refiere la inexorable "**caída de un telón**" o cierre de cortina negra que desciende y le amputa progresivamente el campo visual. - La alteración topográfica de las entopsias es **contralateral** a la retina lesionada (ej: Si se ven entopsias inferiores temporales, la retina afectada se está desprendiendo en la zona súperonasal). - **Causas**: - Retinopatías proliferativas y exudativas (tracción), comúnmente en la historia. - Factores mecánicos: **Alta Miopía** (tienen globo grande y retina adelgazada), Trauma directo ocular contuso de gran energía. - **Tratamiento**: El manejo es 100% quirúrgico (retinopexia) en pabellón de oftalmología en el menor tiempo posible para rescatar fóvea.

2. Trombosis de la Vena Central de la Retina (TVCR)

Es el infarto hemorrágico de la retina. Demora minutos a pocas horas en claudicar la capacidad óptica plena. - **Clínica**: Escotomas severos que aumentan en pocos días; amaurosis rápida pero casi siempre el paciente **conserva algo mínimo de resto visual** (ej: logrando contar dedos o distinguir luz gruesa). - **Causas Frecuentes**: Secuelas de **Retinopatía Hipertensiva** crónica con alteraciones en los cruces arteriovenosos, trombofilias endógenas y daño cardiovascular pesado. - **Fondo de Ojo Patognomónico**: Clásicamente descrita en las retinas hemorrágicas de "color rojo fuego" o aspecto generalizado a "**Retina como Pizza**" (exudados y hemorragias densas multiformes diseminadas de sangre). - **Tratamiento Médico**: Terapia oftalmológica especializada mediante fármacos Anti-angiogénicos (Anti-VEGF intravítreos) y observación minuciosa; en complicaciones de neovasos se fotocoagulará.

3. Oclusión de la Arteria Central de la Retina (OACR)

El infarto blanco isquémico de la retina; su cuadro es absolutamente catastrófico y súbito (en escasos segundos el sujeto pierde toda función óptica). - **Clínica**: **Amaurosis súbita total**. El campo visual es negro absoluto (no cuenta dedos, no distingue luz de sombra). Manifiesta **Defecto Pupilar Aferente (Signo pupilar de Marcus Gunn)** directo. - **Causas**: Es un fenómeno eminentemente tromboembólico con impacto primario: **Émbolos arteriales provenientes de placa ateromatosa en Carótida Interna** y subsidiariamente en arritmias cardíacas embolígenas (FA). - **Fondo de Ojo Patognomónico**: Retina totalmente isquémica de intenso color blanco y acuosa pálida; con contraste de la arteria cilio-retinial al centro formando la célebre y lúgubre **Macula en Mancha Rojo Cereza**. - **Gestión Inmediata Estratégica**: Obliga el manejo paralelo como un formalísimo **Accidente Cerebrovascular (ACV o TIA)**, por la altísima correlación de infarto inminente en territorio de

la cerebral media. (Requiere urgente tomografía cerebral, tamizaje con Eco-Doppler Carotídeo de vasos de cuello, Holter de arritmia en ancianos y control preventivo neurológico).

4. Hemorragia Vítrea

Extravasación pura de sangre fresca invadiendo la gelatina central (Humor Vítreo) por rotura de neovasos frágiles e insolentes. Instauración muy veloz y súbita amaurosis en paciente de riesgo. - **Signo cardinal diferenciador de otras patologías súbitas**: Pérdida y abolición total o severa alteración del **Rojo Pupilar** inicial al iluminar directamente con oftalmoscopio básico el ojo (lo que no pasa con ningún cuadro arterial/venoso per sé). - **Causas**: En Chile subyace primeramente una **Retinopatía Diabética Proliferativa** preexistente descompensada de largo plazo. - **Fondo Clínico de Ojo**: Ocluido totalmente. Refleja nubarrones de hemorragia general turbia imposibilitando identificar relieves anatómicos. - **Manejo**: Vigilia en espera de reabsorción hematomielítica natural por semanas. De empeorar o no reabsorberse, el especialista opera con **Vitrectomía** evacuadora exhaustiva total.

5. Neuritis Óptica

Cuadro inflamatorio agudo puro de las fibras intrafasciculares miélicas profundas del II Par craneal, y se instaura subagudamente en un margen intermedio de horas a pocos días con bastante dolor al movimiento. - **Demografía cardinal**: Incidencia clásica orientada a **Mujeres jóvenes** como pico epidemiológico. - **Clínica Típica**: Descenso de agudeza visual sumada a un ineludible y notable **Defecto Pupilar Aferente (Pupila de Marcus Gunn)**. - **Sospecha de Gran Importancia**: Su causa es marcadamente autoinmune primaria mediada en parte por afectación de la producción desordenada del oligodendrocito del SNC. Es uno de los hallazgos precursores debutantes y comorbilidad fiel de la nefasta **Esclerosis Múltiple**. - **Herramienta Diagnóstica Gold Estándar**: Requiere insustituible **Resonancia Magnética (RM) Encefálica y Medular** en busca contigua de placas periventriculares de desmielinización concomitante. - **Manejo Agresivo Sistémico**: Inyección generalizada de Corticoides intravenosos como ataque de pulso biológico de Choque y enlentecimiento general de la neuromielitis (ej: Metilprednisolona Intravenosa a dosis letales inflamatorias, sumando luego anticuerpos monoclonales integrales tipo *Natalizumab* administrados por equipo subespecialidad Neurológica).

NOTA CLÍNICA

No confundas con la **Edema de Papila Bilateral** (Que también afecta el fondo retiniano engrosando clásicamente la papila como coliflor por Edema) pero cuyo sello etiológico indiscutible y por lejos principal no es la neuritis per sé, sino la **Hipertensión Intracraneal (HIC)** con fuertes y constantes cefaleas masivas y matutinas unidas a intensos vómitos agudos asociados con patología neurotumoral de alta morbilidad neurológica y fatal, mas no oftalmológica aguda en su concepción misma funcional inicial de presentación típica.

6. Neuropatía Óptica Isquémica (NOIA)

Comparativamente igual de cataclísmica y súbita en la temporalidad visual instalada a como lo ejecuta y lo imita de base la obliteración local patológica de la arteria central de la retina. Pero posee notables demografías etiológicas que inciden obligatoriamente en otro esquema semiológico para un manejo certero y enfocado que la diferencia de la trombótica arterial joven. - **Demografía y Claves**: Relativamente exclusiva y propensa a gatillarse en el **Adulto Mayor**. - **Causas Principales**: 1. Su vinculación sistémica y más alarmante

se asocia irrenunciablemente como una catastrófica secuela isquémica biológica terminal en el marco de la autoinmune sistémica **Arteritis de Células Gigantes (Arteritis de la Temporal)** en pacientes geriátricos, sumado a un historial crónico clásico del mes previo abarcando dolores agudos tipo claudicación mandibular intensiva isquémica secundaria severa matinal unida a inflamación arterial superciliar unilateral e induración patognomónica táctil. 2. Factores pesados de embolización cardiovascular natural o placa ateromatosa propia de grandes lechos arteriales crónicos basales generalizados, como factor isquemizante terminal en territorio neurológico. - **Diagnóstico y Manejo Geriátrico de Rescate:** Se evalúa siempre y prioriza fundamentalmente y directamente primero con exclusión neurológica total asimilada con ayuda técnica obligatoria de RM (RMN cerebral). - De sospecharse fuertemente Arteritis de Temporal (NOIA-Arterítica), se administran **Masivas dosis agresivas y plenas Corticoidales intravenosas (Prednisona plena o Metilprednisolona I.V. inicial inmediata para el rescate y eventual de la contraparte de salud y evitar ceguera en el segundo ojo lateral)** antes incluso que biopsiar el temporal como norma vital y biológica clásica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un médico general está revisando las causas de pérdida súbita de visión para el EUNACOM. ¿Cuál de las siguientes patologías produce un defecto pupilar aferente como parte de su presentación clínica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para pérdida súbita de visión - resumen. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El defecto pupilar aferente se produce en: neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica, oclusión de arteria central de la retina y desprendimiento de retina.
- Solo la neuritis óptica se asocia a esclerosis múltiple; la neuropatía óptica isquémica se asocia principalmente a arteritis de la temporal.
- La alteración del reflejo rojo es hallazgo patognomónico de hemorragia vítrea y permite diagnosticarla al examen general.
- Las fotopsias y entopsias preceden principalmente al desprendimiento de retina; la hemorragia vítrea puede dar entopsias pero raramente fotopsias.
- La velocidad de instalación es clave: oclusión arterial y neuropatía isquémica son en segundos; hemorragia vítrea y oclusión venosa en minutos; neuritis y desprendimiento en horas a días.
- Los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión y diabetes se asocian más a las oclusiones vasculares retinianas, no a la neuritis óptica.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN - RESUMEN)**PREGUNTA 1**

Un médico general está revisando las causas de pérdida súbita de visión para el EUNACOM. ¿Cuál de las siguientes patologías produce un defecto pupilar aferente como parte de su presentación clínica?

- A) Hemorragia vítrea
- B) Oclusión de la vena central de la retina
- C) Cataratas bilaterales
- D) Neuritis óptica
- E) Glaucoma agudo de ángulo cerrado

PREGUNTA 2

Una mujer de setenta y cinco años con antecedente de polimialgia reumática consulta por pérdida visual brusca del ojo derecho al levantarse esta mañana. Tiene cefalea temporal derecha y la velocidad de sedimentación está muy elevada. ¿Cuál es la causa más probable de pérdida visual y cuál es el tratamiento urgente?

- A) Neuritis óptica por esclerosis múltiple; tratamiento con metilprednisolona intravenosa
- B) Neuropatía óptica isquémica por arteritis de la temporal; tratamiento urgente con corticoides
- C) Hemorragia vítrea por retinopatía diabética; tratamiento expectante
- D) Oclusión de la arteria central de la retina de causa embólica; tratamiento con trombolisis
- E) Desprendimiento de retina por degeneración macular; tratamiento quirúrgico urgente

PREGUNTA 3

Respecto a la velocidad de instalación de las causas de pérdida súbita de visión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La neuritis óptica es la que se instala más rápido, en segundos
- B) La hemorragia vítrea y la oclusión venosa se instalan en minutos
- C) El desprendimiento de retina se instala de manera súbita en segundos
- D) La oclusión venosa se instala siempre más rápido que la oclusión arterial
- E) Todas las causas de pérdida súbita de visión se instalan de manera idéntica

RESUMEN: PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN - RESUMEN

Esta clase es un resumen comparativo de las causas de pérdida súbita de visión, diseñado para consolidar los conceptos aprendidos en la clase anterior y facilitar la resolución de preguntas EUNACOM. Se repasan cuatro ejes diagnósticos clave. Primero, el defecto pupilar aferente: las patologías que lo producen son la neuritis óptica como la más importante, la neuropatía óptica isquémica, la oclusión de la arteria central de la retina y el desprendimiento de retina, este último produciendo un defecto relativo. Segundo, la asociación con esclerosis múltiple: solo la neuritis óptica se asocia a esclerosis múltiple. Tercero, la asociación con arteritis de la temporal: la causa más frecuentemente asociada es la neuropatía óptica isquémica, aunque también puede ocurrir en la oclusión de la arteria central de la retina. Los factores de riesgo cardiovascular como hipertensión y diabetes en cambio se asocian más a la oclusión de vasos retinianos. Cuarto, la alteración del reflejo rojo: solo la hemorragia vítrea produce alteración del reflejo rojo de manera característica, y esto es patognomónico. Quinto, las precursoras con fotopsias y entopsias: principalmente el desprendimiento de retina, aunque la hemorragia vítrea también puede dar entopsias. Sexto, la velocidad de instalación: la oclusión arterial y la neuropatía óptica isquémica son las más rápidas en instalarse, en segundos. La hemorragia vítrea y la oclusión venosa se instalan en minutos. La neuritis óptica y el desprendimiento de retina son los más lentos, instalándose en horas o incluso días. Este eje de velocidad permite diferenciar entre causas cuando otras características se superponen.